

HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA

ENTREVISTAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

RESPUESTAS MODELO · SOLO LO QUE DEBE DECIR EL FUNCIONARIO

Reacreditación 2026

AOC 1.1 · RH 4.2.1 · RH 4.2.2 · INS 2.1 · APE 1.2
GCL 2.3 · REG 1.1 · DP 1.2 · GCL 1.9 · DP 3.1 · DP 5.1 · GCL 1.12

QUÉ DEBE
LOGRAR EL
FUNCIONARIO

Reconocer
Actuar
Informar
Demostrar

CÓMO DEBE RESPONDER EL FUNCIONARIO

La respuesta debe sonar natural y en primera persona. No es necesario recitar el protocolo completo: debo demostrar que sé reconocer la situación, actuar correctamente y conocer el flujo institucional.

1 • ME UBICO

“Me encuentro en mi unidad/servicio...” y explico lo que corresponde hacer allí.

2 • RECONOZCO

Digo qué situación identifico y por qué constituye un riesgo o requiere una acción.

3 • ACTÚO

Explico primero la acción inmediata y luego la secuencia.

4 • AVISO

Indico a quién informo, número/canal cuando corresponda y dónde queda el registro.

5 • DEMUESTRO

Si me piden mostrarlo, ingreso al sistema o indico físicamente dónde está el recurso/protocolo.

6 • NO INVENTO

Si una acción depende de mi perfil, digo que accedo según mi función y el Anexo correspondiente.

EMERGENCIA CON RIESGO VITAL

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace si encuentra a una persona que podría estar en riesgo vital?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Me encuentro en mi servicio. Primero verifico la seguridad del entorno y compruebo rápidamente si la persona responde y si respira. Si no responde y no respira, o presenta respiración agónica o ineficaz, reconozco una emergencia de riesgo vital y activo Código Azul.”

SECUENCIA QUE DEBO DECIR

1. Compruebo respuesta y respiración en aproximadamente 5 a 10 segundos.
2. Si no responde o la respiración es ausente/agónica/ineficaz, activo Código Azul.
3. Permanezco con la persona y comienzo/continúo RCP básica si corresponde.
4. Si al final no corresponde Código Azul, informo al equipo para cancelar la activación.

ACTIVACIÓN Y UBICACIÓN

1. Desde teléfono interno: 418725. Desde celular: 412688725.
2. Debo decir: “Código Azul”, lugar exacto donde ocurre la emergencia y una descripción breve.
3. Si los teléfonos no funcionan, activo a viva voz para que un funcionario cercano realice el llamado.
4. Si no corresponde Código Azul, se deriva el evento según el flujo institucional y se informa la situación al equipo.

ACCIDENTE CORTOPUNZANTE / EXPOSICIÓN A SANGRE

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace inmediatamente después de un accidente cortopunzante o exposición a sangre/fluidos?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Realizo inmediatamente el manejo local según la zona expuesta. Si es una herida o punción, lavo con abundante agua y jabón; las pequeñas heridas y pinchazos también pueden limpiarse con un antiséptico. Si la exposición es en mucosas u ojos, realizo irrigación/lavado inmediato y abundante. Luego informo de inmediato a mi jefe directo o, en horario inhábil, al jefe de turno.”

MANEJO INMEDIATO

1. Herida o pinchazo: lavado inmediato con abundante agua y jabón.
2. Pequeñas heridas/pinchazos: puede utilizarse antiséptico según el protocolo.
3. Mucosas: irrigación/lavado inmediato y abundante.
4. Ojos: irrigación inmediata y abundante, evitando retrasar la atención.

CONTINUIDAD DEL FLUJO

1. Comunico el accidente inmediatamente al jefe directo; en horario inhábil, al jefe de turno.
2. Debo ser atendido rápida y oportunamente, antes de 2 horas, por médico de turno en Urgencia.
3. El médico realiza valoración inicial y categorización del riesgo para definir manejo frente a VIH y hepatitis B/C.
4. Posteriormente continúo con el flujo institucional, incluyendo PCI y seguimiento.

ACCIDENTE CORTOPUNZANTE · PEP Y SEGUIMIENTO

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué pasa después de la atención inicial y qué debe saber del tratamiento?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“El médico de Urgencia realiza la valoración y determina el nivel de riesgo. Si el accidente es de alto riesgo, se activa de inmediato el protocolo correspondiente. Si existe indicación de profilaxis post exposición, el tratamiento antirretroviral PEP debe ser indicado por el médico según la evaluación del riesgo. Yo no inicio ni indico por mi cuenta el tratamiento.”

LO QUE DEBO RECORDAR

1. Atención médica antes de 2 horas.
2. Categorización del riesgo de la exposición.
3. Alto riesgo: activar inmediatamente el protocolo de acción frente a exposición de alto riesgo.
4. PEP antirretroviral: la indica el médico según la evaluación del riesgo.

DESPUÉS DE URGENCIA

1. El funcionario afectado continúa con entrevista/seguimiento con la enfermera encargada de PCI.
2. Se realizan las acciones institucionales de seguimiento y prevención que correspondan.
3. Si el caso es de bajo riesgo, se continúa según el flujo institucional y consejería con PCI.
4. Debo registrar y seguir las indicaciones entregadas por los profesionales responsables.

ACCIDENTES Y DERRAMES CON ANTINEOPLÁSICOS

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace si hay exposición de una persona o un derrame de antineoplásicos?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Primero protejo a la persona y evito que otros se expongan. Distingo si se trata de una exposición personal o de un derrame en superficie. Actúo con el EPP y el kit/procedimiento institucional correspondiente, informo la exposición y realizo el manejo y eliminación segura de los residuos.”

SI ES SOBRE UNA PERSONA

1. En piel: retirar la contaminación y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
2. En ojos o mucosas: irrigar de inmediato y abundantemente y solicitar evaluación.
3. Informar el accidente según el flujo institucional.
4. Solicitar evaluación médica cuando corresponda.

SI ES UN DERRAME EN SUPERFICIE

1. Delimitar/proteger el área para evitar nuevas exposiciones.
2. Utilizar EPP y el kit de derrame disponible.
3. Contener y retirar el material siguiendo el procedimiento institucional.
4. Eliminar los residuos según las disposiciones establecidas.

PLAN DE EVACUACIÓN · CONDUCTA Y ORGANIZACIÓN

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué debe hacer durante una emergencia y cómo se organiza la evacuación?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Ante una emergencia mantengo la calma y sigo las instrucciones. No corro, no grito ni genero pánico. Sigo las vías de evacuación y la señalética, no uso ascensores y ayudo a quienes más lo necesitan. La ruta puede variar según el lugar donde ocurre la emergencia y el monitor de emergencia determina la ruta más segura y expedita.”

TIPOS DE EMERGENCIA

1. Incendio.
2. Sismo.
3. Inundación.
4. Amenaza de bomba.
5. Caída de avión.

CADENA DE MANDO Y COMUNICACIÓN

1. Jefe de la emergencia: Director o quien lo subrogue.
2. Jefe operativo: Encargado del Área de Logística del Hospital.
3. Monitor de emergencia: jefatura de cada área o su subrogante.
4. Comunicación: altoparlantes y teléfonos; como alternativas, radios VHF-HF y comunicación a viva voz.

PLAN DE EVACUACIÓN · VÍAS Y ZONAS DE SEGURIDAD

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Cuál es mi vía de evacuación y zona segura?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“La zona de seguridad depende del lugar donde me encuentre. Conozco la vía señalizada de mi área y sigo las instrucciones del monitor de emergencia. No fijo una ruta distinta si la emergencia ha cambiado las condiciones del establecimiento.”

DÓNDE DEBO IR

1. 1.er piso, edificios A, B y C → Zona de Seguridad N.º 1: lado derecho, frente al hospital.
2. 1.er piso, edificios D, E, F y G → Zona de Seguridad N.º 2: lado izquierdo, frente al hospital.
3. Pisos 2º, 3º y 4º → descenso por escaleras y evacuación hacia Urgencia, Zona de Seguridad N.º 1.
4. Pisos zócalos → zona transitoria: patio de descarga, sector Economato; posteriormente Zona N.º 1.
5. Zona alternativa → Zona de Seguridad N.º 3, sector posterior del establecimiento/cancha, cuando las otras zonas estén afectadas.

REGLAS CLAVE

1. No correr, no gritar y no generar pánico.
2. No utilizar ascensores.
3. Seguir señalética y vías de evacuación.
4. Ayudar a quienes más lo necesitan.
5. Los teléfonos externos de emergencia son Bomberos 132, Carabineros 133 y SAMU 131.

EVACUACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Cómo se evacúan los pacientes hospitalizados?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Para los pacientes hospitalizados se utiliza la técnica del semáforo. El color determina cómo se evacúa según la condición del paciente y la capacidad de hacerlo. La evacuación se realiza en el orden establecido por el equipo y sin poner en riesgo al paciente ni al personal.”

TÉCNICA DEL SEMÁFORO

1. ROJO → no evacúa: paciente crítico.
2. AMARILLO → evacuación con apoyo.
3. VERDE → evacuación por sus propios medios.
4. El orden y la ruta pueden modificarse según la emergencia y sus condiciones.

MI ROL DURANTE LA EVACUACIÓN

1. Conozco la indicación del monitor de emergencia.
2. Acompaño y ayudo a los pacientes que requieren apoyo.
3. Utilizo la vía de evacuación definida para mi ubicación.
4. Mantengo la calma, sigo instrucciones y evito generar pánico.

MANEJO DE MATERIAL CONTAMINADO

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace con el material usado antes de enviarlo a la Central de Esterilización?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Realizo un arrastre mecánico bajo el chorro de agua de la llave o mediante un enjuague, arrastrando la materia orgánica. Luego dejo el material en un contenedor de material contaminado en el área sucia, para su posterior traslado a la Central de Esterilización, donde se realiza el lavado definitivo.”

SECUENCIA

1. Realizo arrastre mecánico inmediatamente.
2. Utilizo chorro de agua de la llave o un enjuague que permita arrastrar la materia orgánica.
3. No dejo el material contaminado expuesto ni lo traslado sin las medidas correspondientes.
4. Deposito el material en el contenedor destinado a material contaminado.

TRASLADO Y EXCEPCIONES

1. El contenedor queda en el área sucia para su traslado posterior a la Central de Esterilización.
2. En la Central se realiza el lavado definitivo y continúa el proceso correspondiente.
3. Excepción: en Dental y Maternidad se utiliza el producto institucional destinado a evitar la adhesión de cemento y materia orgánica.
4. Debo conocer el procedimiento específico de mi unidad.

VIGILANCIA Y NOTIFICACIÓN DE EVENTOS

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué eventos notifico y cómo los notifico?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Si detecto un evento relacionado con la atención, lo registro inmediatamente en la ficha clínica cuando corresponda y lo notifico por SER-Q dentro de las 48 horas siguientes al evento. La notificación es confidencial y permite analizar lo ocurrido, implementar acciones de mejora y prevenir que vuelva a suceder.”

QUÉ DEBO RECONOCER

1. Evento adverso: daño no intencionado al paciente producto de la atención.
2. Evento centinela: suceso inesperado que causa muerte o daño grave, o riesgo potencial de ello.
3. Incidente: evento que pudo causar daño, pero no ocurrió.
4. Near miss: situación que pudo causar daño, pero fue detectada a tiempo.

QUÉ DEBO HACER

1. Detecto y registro el evento en la ficha clínica cuando corresponde.
2. Notifico en SER-Q dentro de 48 horas.
3. Para ECPRI/evento centinela prevenible relacionado con la atención, realizo además la notificación inmediata telefónica según el flujo institucional.
4. Después se analiza el evento, se elabora un plan de mejora, se implementan acciones y se realiza seguimiento.

SER-Q · ACCESO Y NOTIFICACIÓN

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Cómo accede a los protocolos y cómo demuestra que puede notificar?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Ingreso a SER-Q desde serq.cl, selecciono Ingreso Clientes SER-Q y entro con mi perfil institucional. En el menú selecciono Búsqueda de Documentos para revisar el protocolo vigente antes de realizar un procedimiento. Para notificar selecciono Notificar un Evento Adverso, completo la ficha y la envío.”

ACCESO A PROTOCOLOS

1. Ingreso a serq.cl y selecciono “Ingreso Clientes SER-Q”.
2. Accedo con mi perfil institucional.
3. Voy a “Búsqueda de Documentos”.
4. Busco el protocolo y verifico que sea la versión vigente antes de aplicarlo.

NOTIFICACIÓN

1. En el menú selecciono “Notificar un Evento Adverso”.
2. Completo la información requerida y envío la notificación.
3. También puedo acceder al formulario mediante el código QR institucional.
4. Si el evaluador lo solicita, debo poder demostrar el ingreso y la navegación.

FICHA CLÍNICA · TIPO Y SOPORTES

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué tipo de ficha clínica tiene el hospital y cuáles son sus soportes?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“La ficha clínica del Hospital Kallvu Llanka es única e individual y de tipo mixta. La información puede encontrarse en soporte electrónico, en soporte físico o papel y en documentos digitalizados. Todos los soportes forman parte de la historia clínica y deben mantenerse íntegros, confidenciales, disponibles y trazables.”

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

1. El RUN es el código único que permite vincular los antecedentes de una persona.
2. La información de los distintos soportes debe corresponder al mismo usuario.
3. La ficha no es solamente electrónica: el soporte papel y los documentos digitalizados forman parte del sistema institucional.

QUÉ PUEDE ENCONTRARSE

1. Electrónico: Rayen Eloísa y plataformas complementarias según el perfil.
2. Papel: registros y documentos clínicos que aún permanecen en soporte físico.
3. Digitalizado: documentos que pueden integrarse a la ficha electrónica y/o quedar almacenados en repositorios institucionales definidos, como servidores NAS.
4. También existen documentos satélite, como tarjetones, fichas perinatales y otros registros, cuya custodia depende de la unidad.

FICHA CLÍNICA · ACCESO, PERFIL Y PAPEL

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Cómo accede a la información de la ficha clínica?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Accedo a la información que corresponde a mi función y al perfil institucional definido en el Anexo N.º 3. Uso mi usuario y mi clave personal, busco al paciente y visualizo solo lo autorizado. Si necesito información que está en otro soporte o plataforma, utilizo el mecanismo institucional para acceder a ella.”

ACCESO ELECTRÓNICO

1. El sistema depende de mi función: no todos los funcionarios tienen acceso a todas las plataformas.
2. Mi perfil está definido en el Anexo N.º 3.
3. Mi clave es personal, confidencial e intransferible.
4. El acceso debe estar relacionado con la atención directa y con las funciones del cargo.

ACCESO AL SOPORTE PAPEL

1. La ficha papel está bajo custodia de Archivo/Fichero.
2. Se solicita por correo electrónico con trazabilidad de entrega y devolución.
3. Jefatura Unidad Gestión de Usuarios: nathalie.montecino@hikll.cl.
4. Subrogante: pamela.vera@hikll.cl. Con copia para trazabilidad: somecanetefichero@gmail.com.
5. Los documentos satélite se consultan en el lugar de custodia correspondiente.

FICHA CLÍNICA · EXCEPCIONES, DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué debe saber sobre RUN, documentos digitalizados y conservación?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“La ficha sigue siendo única aunque la información esté en distintos soportes. Si una persona no tiene RUN, se utiliza el mecanismo de identificación institucional correspondiente. Los documentos que se digitalizan pueden quedar incorporados en la ficha electrónica o almacenados en los repositorios institucionales definidos. El acceso siempre depende de mi perfil.”

EXCEPCIONES AL RUN

- 1.** Migrante sin RUN: se utiliza el NIP, número de identificación provisorio, según el flujo institucional.
- 2.** Recién nacido: se vincula inicialmente con el RUN de la madre hasta contar con su identificación propia.
- 3.** Paciente NN: se registra con la identificación provisorio correspondiente y, una vez identificado, se realiza la vinculación/homologación de sus antecedentes.
- 4.** Los antecedentes de una misma persona deben consolidarse en una ficha única.

RESGUARDO Y CONSERVACIÓN

- 1.** Los documentos en papel se mantienen bajo custodia, en lugares destinados para ello y con acceso controlado.
- 2.** La información digitalizada puede quedar en la ficha electrónica o en almacenamiento institucional definido, como NAS.
- 3.** Al finalizar una atención, la ficha papel debe quedar devuelta/guardada y la sesión electrónica debe quedar cerrada.
- 4.** El material de preparación institucional establece como criterio de conservación 15 años desde el fallecimiento o desde la última atención, según corresponda.
- 5.** El acceso es confidencial y solo para fines de atención y funciones autorizadas.

GESTIÓN DE RECLAMOS Y SOLICITUDES CIUDADANAS

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace si un usuario quiere presentar un reclamo?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Oriento al usuario hacia OIRS, que recibe, registra y tipifica las solicitudes ciudadanas en la plataforma OIRS MINSAL. El reclamo sigue el flujo institucional: OIRS lo deriva a la jefatura correspondiente para investigación, se elabora el informe, OIRS prepara la respuesta y Dirección la revisa y firma. El plazo general de respuesta es de 15 días hábiles.”

RECLAMO DE CURSO NORMAL · TIPO 1

1. OIRS recibe y registra el reclamo.
2. Lo deriva a la jefatura de la unidad o servicio para investigación, con un plazo de 5 días hábiles.
3. La jefatura entrega informe con averiguaciones, conclusiones y medidas de mejora cuando corresponda.
4. OIRS prepara la carta; Dirección revisa, firma y la respuesta se envía al usuario.

CUANDO HAY MEDIDA ADMINISTRATIVA · TIPO 2

1. Aplica a reclamos de competencia técnica que describen efectos/consecuencias no deseadas y ameritan medida administrativa.
2. OIRS informa y deriva según el flujo; puede solicitarse sumario o investigación sumaria a la Dirección del SSA.
3. El establecimiento responde al usuario en 15 días hábiles informando el curso de la medida.
4. El proceso administrativo puede extenderse hasta 180 días hábiles para la entrega de información sobre su resultado.

CONTENCIÓN FÍSICA EN AGITACIÓN PSICOMOTORA

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué debe hacer si un paciente requiere contención física?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“La contención física es la última medida dentro de la secuencia de intervención. Primero se consideran contención emocional, ambiental y farmacológica; si es necesaria la contención física, verifico la indicación médica y las condiciones establecidas por el protocolo, informo al paciente, realizo la instalación segura, registro y mantengo vigilancia y reevaluación.”

ANTES Y DURANTE LA INSTALACIÓN

1. Verifico indicación médica, fármacos a utilizar, consentimiento informado y/o medidas de internación, según corresponda.
2. Informo al paciente qué procedimiento se realizará y el motivo.
3. Abordo protegiendo la cabeza, llevo al paciente a la unidad y verifico que la cama esté frenada.
4. Inmovilizo extremidades superiores e inferiores y utilizo los elementos establecidos; tórax con arnés/sábana y faja abdominal si corresponde, respetando las excepciones para embarazadas.

VIGILANCIA, RETIRO Y REGISTRO

1. Registro horario de instalación y localización de las contenciones.
2. En agitación psicomotora, reevaluo cada 15 minutos.
3. En delirio/síndrome confusional, se utilizan las sujeciones mínimas y se reevalúa según el intervalo establecido en el protocolo.
4. Retiro progresivamente cuando termina la agitación.
5. Completo el formulario de notificación de contención física/farmacológica y lo entrego a supervisor para el flujo institucional y envío consolidado.

INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué debe hacer si quiere realizar una investigación en seres humanos?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Sí existen investigaciones en seres humanos. Si quisiera realizar una, no la inicio directamente. Presento el proyecto por el flujo institucional y debe ser evaluado por el Comité de Ética Científico/Provincial correspondiente antes de comenzar.”

INGRESO Y REVISIÓN

1. Presento el proyecto a Subdirección Médica.
2. En formato digital, los antecedentes se envían en PDF a cecp@ssarauco.cl y cecp.ssa@gmail.com.
3. También puede presentarse físicamente por Oficina de Partes del hospital; si involucra más de una subred, por Oficina de Partes del SSA.
4. Si corresponde, los antecedentes son remitidos a la Dirección del Servicio de Salud Arauco.

EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN

1. El Comité asigna número y realiza la recepción conforme; contempla hasta 30 días para la primera evaluación.
2. Si es urgente, puede convocarse reunión extraordinaria; si no, se presenta en reunión ordinaria.
3. El Comité evalúa y emite la decisión correspondiente.
4. Antes de iniciar el estudio deben incorporarse las modificaciones solicitadas y contar con la autorización expresa de los directores de los establecimientos involucrados.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Existe un Comité de Ética Asistencial en el hospital y cómo consulto un caso?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“No existe un Comité de Ética Asistencial propio del Hospital Kallvu Llanka. Existe un Comité de nivel provincial, dependiente de la Dirección del Servicio de Salud Arauco. Si tengo una situación que requiere evaluación ética, utilizo el flujo institucional y no tomo la decisión de manera aislada.”

CUÁNDO PUEDE CONSULTARSE

1. Duda sobre la competencia de una persona para adoptar una decisión autónoma, después de una evaluación clínica integral.
2. Decisión autónoma que expone a graves daños o riesgo de morir, habiendo agotado las instancias de información.
3. Posible aplicación de alta forzosa.
4. Persona con discapacidad psíquica o intelectual sin capacidad de expresar voluntad frente a tratamientos invasivos irreversibles.
5. Rechazo del usuario/representante a tratamientos o limitación del esfuerzo terapéutico. En menores se considera especialmente su interés superior y derecho a ser informado y expresarse.

FLUJO Y CONTACTO

1. Se envía el “Formulario de presentación de Caso Clínico Comité de Ética Asistencial” en PDF al SDM/comité.
2. Correos institucionales: cecp@ssarauco.cl y cecp.ssa@gmail.com, con copia a la dirección técnica.
3. También puede presentarse en formato físico a Dirección para envío mediante Oficina de Partes del SSA.
4. El Comité dispone de hasta 30 días para la primera evaluación.
5. Las recomendaciones se entregan por correo electrónico, mediante carta de recomendaciones, dentro del plazo institucional indicado.

IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PACIENTE

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Cómo identifica al paciente antes de realizar un procedimiento?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“La identificación se realiza mediante brazalete identificadorio. Antes de realizar un procedimiento verifico que los datos del brazalete correspondan al paciente y los contrasto con la ficha clínica, DAU o documento de identificación. No realizo el procedimiento si el paciente no tiene identificación o si los datos no corresponden.”

SISTEMA Y VERIFICACIÓN

1. El brazalete puede ser digital o manual; el manual se utiliza en casos especiales, contingencia o unidades sin impresora.
2. Verifico los datos mediante ficha clínica, DAU, documento de identificación y, cuando corresponde, con el paciente o acompañante/representante.
3. El brazalete debe permanecer durante toda la hospitalización.
4. Si se deteriora, queda ilegible, contiene datos erróneos o se retira accidentalmente/voluntariamente, debe reponerse.

CASOS QUE DEBO CONOCER

1. Recién nacido: brazalete inmediatamente al nacimiento y concordancia con datos de la madre.
2. Paciente pediátrico: instalación por TENS de turno.
3. Paciente con compromiso de conciencia: identificación obligatoria independiente de la edad.
4. Ingreso directo a pabellón/sala integral de partos: aplicación durante el proceso preoperatorio/procedimiento ambulatorio.
5. Si el brazalete ocupa el sitio donde se instalará una vía, se retira y se repone inmediatamente en la extremidad contraria.

IDENTIFICACIÓN · SITUACIONES ESPECIALES

PREGUNTA DEL EVALUADOR ¿Qué hace si el paciente no puede llevar el brazalete o si recibe uno desde otro establecimiento?

RESPUESTA QUE DEBE DAR EL FUNCIONARIO

“Si el paciente recibe atención desde otro establecimiento, verifico los datos obligatorios. Si no cumplen el protocolo, repongo el brazalete al ingreso. Si son correctos, puedo mantenerlo. Si por una condición clínica no es posible mantenerlo en una extremidad, aplico la alternativa establecida por el protocolo para mantener la identificación segura.”

REPOSICIÓN Y RETIRO

1. Durante la hospitalización, el retiro accidental o voluntario obliga a reponer el brazalete.
2. Si se necesita instalar una vía en la extremidad donde está el brazalete, se cambia inmediatamente a la extremidad contraria.
3. En paciente fallecido, el brazalete se retira al momento de entregar el cadáver a sus familiares en la morgue.
4. Después del alta, el paciente/familiar retira el brazalete en el domicilio; en RN, lo retira la madre.

REGLA DE SEGURIDAD

1. Toda persona que recibe al paciente en una unidad o servicio verifica que el brazalete corresponda a los datos reales.
2. Antes de cualquier procedimiento se verifica la identificación.
3. No se realiza un procedimiento a un paciente que no tenga brazalete de identificación, hasta resolver la situación.
4. La identificación protocolizada busca prevenir eventos adversos derivados de una identificación incorrecta.

REPASO FINAL · LO QUE DEBE PODER DECIR CADA FUNCIONARIO

AOC 1.1

Reconozco riesgo vital, compruebo respuesta/respiración, activo Código Azul y digo lugar + situación.

RH 4.2.1

Lavo/irriego según zona, aviso, Urgencia antes de 2 h, categorización médica, PEP si corresponde y seguimiento.

RH 4.2.2

Distingo exposición personal de derrame de antineoplásicos y actúo con EPP/kit.

INS 2.1

Conozco conducta, mando, comunicación, vía, zona segura y técnica del semáforo.

APE 1.2

Realizo arrastre mecánico, deposito en contenedor de contaminado y traslado a Central.

GCL 2.3

Registro, notifico en SER-Q dentro de 48 h y conozco QR y eventos de mi servicio.

REG 1.1

Sé que la ficha es mixta, conozco RUN, excepciones, soportes, digitalización y mi perfil.

DP 1.2

Oriento a OIRS y conozco el flujo de reclamo Tipo 1 y Tipo 2.

GCL 1.9

Conozco las etapas de contención, instalación, vigilancia, reevaluación, retiro y notificación.

DP 3.1

Sé que una investigación requiere evaluación ética y autorizaciones antes de iniciar.

DP 5.1

Conozco el Comité provincial, cuándo consultar y cómo enviar el caso.

GCL 1.12

Verifico el brazalete antes de procedimientos y conozco reposición y situaciones especiales.